



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صباح عبدالعزيز عمر الصياده

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة اول العنوان : --

رقم البطاقة : 26008251700141 رقم التليفون : 01155580171 تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-08-1960 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات الاروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صباح عبدالعزيز عمر الصياده National ID: 26008251700141	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Dms



سوار

وهادمو برام

على الشرى

الاعين

والايسر



mm/dd/yyyy



MDT FORM

Name: Sabah عبدالعزیز عمر الصبيحة	MRN: 9941
Age: 66 Y	ID:
Menopausal Status: POST MENOPA	Phone: 01155580171
NRS SCORE:	Marital Status:
BMI:	Family History:
CO Morbidity: DM . HTN	Reason Of MDT:

Clinical Data:

BX: IDC GII
ER 8/8 PR 3/8 HER NEGA KI67

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

65 Y OLD FEMALE , DM . HTN ,, LEFT BREAST MASS 4 MONTHS AGO >>

SONO MAMMOGRAPHY : MASS 3.3 CM X 4.4.AT 23 OCLOCK , 8 MM DEEP TO SKIN
BENIGN LOOKING AXILLARY LN
ACR B

CT CAP 26/04/2026 >> LEFT BREAST , LEFT LN ,
NON SPECIFIC PULMONARY NODULES
D10 . D 12 SMALL LYTIC LESION

BX : IDC GII , ER 8/8 . PR 3/8 , HER2-ULTRA LOW
KI67 : 20%

MRI DORSOLUMBER >> R

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric


Patient's Name: SABAH A.AZIZ OMAR
Date: 2026-04-26
Referred by: Prof.Dr. CT CAP IV
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported left breast carcinoma .

(I) Chest:

- ☐ Part of left breast is out of field of examination , however small mass measuring 3 x 2 cm .
- ☐ Few prominent left axillary lymph nodes , the largest measuring 16 x 9mm
- ☐ Few scattered pulmonary nodules 2 -3mm .
- ☐ No sizable hilar or mediastinal lymph nodes .
- ☐ Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- ☐ No pleural or pericardial collections seen.
- ☐ No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- ☐ The liver is enlarged in size showing homogenous CT density , no focal lesions
- ☐ Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- ☐ No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- ☐ Normal CT appearance of the pancreas, both kidneys, aorta and IVC.

Patient's Name: SABAH A.AZIZ OMAR
Date: 2026-04-26
Referred by: Prof.Dr. CT CAP IV
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- ☐ Normal CT appearance of the spleen
- ☐ Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- ☐ Unremarkable other pelvic organs.
- ☐ No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- ☐ No ascites.
- ☐ D10 and D12 small lytic bony lesions ..
- ☐ No vertebral structural collapse .

OPINION:.

- Few prominent left axillary lymph nodes
- Few scattered pulmonary nodules 2 -3mm likely non specific for follow up
- D10 and D12 small lytic bony lesions for correlation with bone scan ..

Dr.Reham Khedr, MD

Patient Name : الأستاذ / صباح عبد العزيز عمر
Patient No. : 26008251700141
Path No. : 228/26
Sex : Female
Age : 65 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004 '02
Request Date : 25/01/2026
Verification Date : 12/02/2026
Financial Category : فئة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 3 O'clock mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 25/01/2026, at 11:45 am, cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:

- Three fragmented grey white tissue cores, the longest is 1.3 cm. Totally submitted.
- Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma with focal mucinous differentiation.
- * Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Weak nuclear reaction in 1% of tumor cells (score 3/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in 3% of tumor cells (Ultra-low, score (1)).
- Ki67%: 20%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma with focal mucinous differentiation, Grade 2.

IPT:

Verified by :

Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 05/04/2026 09:45:35

Page 1 of 3

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذ / صباح عبد العزيز حمير
Patient No. : 26008251700141
Path No. : 228/26
Sex : Female
Age : 65 Y
Referring Doc :

Request No. : 13004/02
Request Date : 25/01/2026
Verification Date : 12/02/2026
Financial Category : جوسف روسي - افقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 3/8).
- Her2: Ultra-low (score 0) (Faint incomplete membrane expression in 3% of tumor cells).
- Ki67%: 20%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0), no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0 (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 05/04/2026 09:45:35

Page 2 of 3

Printing By : narwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt